PROVA P2 Turma C

1-Cite 2 pigmentos de hemoglobinas :

R:bilirrubina y hemosiderina

2-Dos câmbios Vasculares **característicos** de la inflamacion aguda:

R:Aumento de permeabilidad y vasodilatacion

Obs:vasocostricion no es característico

3-dos sustacia quiotaxicas endógena de origen celular:

R: il-8 , leucotrieno b4 y prostaglandina D2

Completa:

4-La tincion____**rojo congo**____ monstra deposito de material amiloide de color verde manzana ao observar microscópio de luz polarizado.

5- la chamada celular de insulficiencia cardíaca correspoden a macrófago aveolares carregados de _____**_Hemosiderina**____

6- Se denomina ____**Quimiotaxia**_____ al movimento del leucócitos por los tejidos a sitio de lesion por produtos bacterianos.

7- En no processo de calcificacion patológica la organela que se deposita en cálcio es **_Mitocondria**____

8- En la deficiência de alfa antitriprisina se mostra depósitos globulares de eosinófilos de una proteína dos hepatócitos carência causa enfermidade nos paciente ____**Efisema_Pulmonar**_____

9- Uma Paciente de 4 anos

R:**Polvo de carvon**

10- Mujer sana de 73 años cae por las escaleras y se lesiona la cadera derecha. No hay fractura pero la

radiografia revela calcificacion de las pequenas artérias musculares laterales al útero.
R: **Calcificacion Distrofica ou Esclerosis Medial Calcificada.**

11- Cual del seguintes depósitos corresponden a una Calcificacion Distrofica:
a) **Cuerpo de Psamona**

12-Teniendo en conta los seguinte mediadores químicos e seu efectos correspondentes marca la opcion correta:
a)c5b9 opsonizacion
b)TNF- Fiebre
c)Leucotrieno c4 Vasodilatacion
d)Prostraciclina aumento de permeabilida

13-el termino Hialino corresponde :
R:Alteracion en las células o EC que da un aspecto homogéneo, vitrieo y rosado a los cortes histológicos (H&E)

14-en los seguintes pasos presente em reclutamiento de los leucócitos qual deles se encontra em ordem sequencial
a)transmigracion , adesion ,fagositose
b)marginacion , adesion , rodamiento
c)Rodamiento ,adesion ,diapedese
d)migracion ,adesion, transmigracion

15-Com respeito a neumoconiosis es correto afirmar que: tiene dos respuesta certa:
a) Se observan en los pulmones de casi todo los adultos
b) **Es mas pronuciados em pacientes fumadores**
c) No suele provocar nenhuma reacion de lesion tissular

d) **La exposion prolongada a partícula orgânica y inorgânica quase sempe se produz em lugar de tabaco.**

16- Se realiza uma toracocentesis de la cavidade pleural izquierda se obtienen 500 ml de liquido cual de las seguintes característica de este liquido con mayor probalidad que se trata de um exudado:

a) **Alto contenido de proteína**
b) Aspecto claro de proteínas
c) Recuento bajo de leucócitos
d) Baja densidade

17-Un Grupo de pacientes recibe um inibidor de la ciclooxigenasa 2 (cox 2) los hombres adultos teriam insuficiência cardíaca y artrites de pequena articulaciones. Refere que el fármaco haja apresentado certo efectos cual dos seguintes harllazgos es problable refere el grupo que reciibió el fármaco?

a) **Reduccion de dolor articular (prostaglandina)**
b) Numeroso febril
c) Mayo....

18-Una mujer de 58 años ha tenido tos con fiebre durante 3 días. Una radiografía de tórax revela infiltrados en el lóbulo inferior derecho. En un cultivo de esputo crece Streptococcus pneumoniae. La eliminación de estos organismos del parénquima pulmonar se lograría de manera más efectiva mediante la generación de ¿cuál de las siguientes sustancias por el principal tipo de célula inflamatoria que responde a esta infección?

a)Prostaglandina E2
b) Calicreína

c)Leucotrieno B4

d)Peróxido de hidrógeno

19- Una niña de 4 anos há presentado numerosas infecciones por staphylococcus aurius desde lactancia. Las pruebas genéticas muestran um defecto causante de la ausencia de produccion de B-2 integrinas. Cual de las seguintes alteraciones es más probable que ocurra por deficiência de B-2 integrina?

a) Menor produccion de radicales libres (ERRO)

b)Adhesion neutrofillica inadecuada al endotélio

C) Reducion de la fagocitose de bactérias opsonizada

d) Fracaso del processo em el cual losleuccitos se colocan sobre el endotélio de forma transitoria

20- Un hombre de 37 años ha tenido náuseas y vómitos durante 5 semanas. Ayer experimentó un episodio de hematemesis. En el examen físico no presenta hallazgos anormales. Se realiza una endoscopia del tracto gastrointestinal superior y se observa una lesión de 1,5 cm de diámetro en el antro gástrico con **pérdida de la superficie epitelial.** ¿Estos hallazgos son más típicos de cuál de los siguientes procesos patológicos?

a) Absceso

b) Granuloma

c)Gangrena

d) Úlcera

1. **Cita dos patologías que cursan con depósitos de amiloides.**
    a. Mieloma múltiple,
    b. Enfermedad de Alzheimer,
    c. Enfermedad de Parkinson,
    d. Artritis reumatoide,
    e. Colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria intestinal),
    f. Amiloidosis senil,
    g. Síndrome de túnel carpiano secundaria a hemodiálisis,
    h. Tumor de tiroides
2. **Cita pigmentos endógenos que no causan daño a célula**
    a. Melanina
    b. Lipofucsina
3. **Cite signos cardinales de inflamación resultantes de la vasodilatación**
    a. Rubor
    b. Calor
4. **Paciente masculino de 65 años, consulta por palpitaciones. El ECG informa aurícula izquierda esta agrandada por área vascular mitral de 1cm (reducida), donde se constata calcificación de tipo:**
    Distrófica
5. **La _____ es el principal mediador de las fases transitoria y mediata de la inflamación, causante de vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular.**
    Histamina

6. **Se denomina Hialina de Mallory a la acumulación de _____ en células hepáticas relacionadas con el consumo de alcohol.**

   Filamentos intermedios de queratina

7. **En la inflamación aguda, la migración de leucocitos ocurre principalmente a través del endotelio de las _____**

   Vénulas poscapilares/vénulas

Peroxidación de los lípidos de la membrana	Metabolitos del ácido araquidónico	Desoxihemoglobina
Familia de inmunoglobulinas	Complejo de ataque a endomembrana	E-Selectina
Sistema de	Productos de degradación de hemoglobina	Marginación

8. **Moléculas de adhesión, expresado en las células endoteliales, importante para el proceso en el cual leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio de forma transitoria.**

   E-selectina

9. **Las bacterias con fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis, efectos que son facilitados por componentes del plasma sanguíneo**

   Complejo de ataque de membrana

10. **Una mujer 22 años tiene anemia congénita, a referido transfusiones durante muchos años. Ahora tiene un color bronce más oscuro en la piel por depósitos de sustancias**

    Productos de degradación de Hemoglobina

11. **¿Cuál de las siguientes alteraciones es posible encontrar en los cuerpos de Psamoma?**
    a. Ateromas de ateroesclerosis avanzada.
    b. Válvulas cardiacas de ansíanos.
    c. Ganglios linfáticos tuberculosos
    d. **Carcinoma papilar de tiroides.**
12. **La pericarditis en "pan con mantequilla" es un ejemplo típico de inflamación de tipo:**
    a. Serosa
    b. **Fibrinosa**
    c. Supurativa
    d. Ulcerativa
13. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes, marca la alternativa correcta**
    a. Leucotrieno B4 – Vasodilatación (quimiotaxis)
    b. Interleucina 6 – Dolor (fiebre)
    c. **C3b – Opsonización**
    d. Prostaciclina – aumento de la permeabilidad (vasodilatación)
14. **Con respecto a depósito de material amiloide es correcto afirmar que:**
    a. **La tinción usada comúnmente para su visualización es Rojo Congo**
    b. Las sustancias insolubles se depositan en el citoplasma de las células (extracelular e no en el citoplasma de la célula)

c. La amiloidosis ... es la forma más frecuente de la amiloidosis senil. (afecta principalmente el corazón)

d. En la amiloidosis secundaria se acumulan amiloides de cadena ligera de las células plasmáticas (amiloidosis primaria)

15. **Analiza los siguientes enunciados sobre acumulación intracelular de pigmentos.**

1. Para confirmas los depósitos de hemosiderina se utilizad la tinción azul de Prusia
2. Las células de insuficiencia cardiaca corresponden a macrófagos alveolares cargados de biliverdina. (hemosiderina)
3. El pigmento de lipocromo es un indicador de lesión por radicales libres y peroxidación lipídica.
4. La antracosis se produce por exposición prolongada a sustancias inhaladas, como el carbón, e indicen una reacción fibroblástica en los pulmones.

De estas, ¿cuáles corresponden a respuestas correctas?

a. 1 y 3

b. 1 y 4

c. 2 y 3

d. 3 y 4

16. **Los Cuerpos de Russel en las células plasmáticas del bazo de un hombre de 60 años están llenos de:**

a. Trans...

b. AAT

c. **Inmunoglobulina**

d. Beta-2-microglobulina

17. **En la toracocentesis realizada en la cavidad pleural izquierda subtiene un líquido amarillento y turvio que tiene un recuento de leucocitos aumentado con predominio de neutrófilos. En tinción de gram muestra cocos gram +. ¿Cuál de los siguientes términos describen por el proceso?**
    a. Exudado fibrinoso
    b. Ultrafiltrado de plasma
    c. Organización y cicatrización
    d. **Exudado purulento**
18. **Hombre de 25 años presenta disnea progresiva en las últimas horas, mediante una toracocentesis se obtiene 200ml de un líquido amarillo ligeramente turbio en la cavidad pleural derecha. El examen citológico del líquido revela múltiples neutrófilos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye para acumulación de este líquido pleural?**
    a. Vasoconstricción arteriola
    b. **Contracción endotelial**
    c. Obstrucción linfática
    d. Liberación de los lisosomas por los neutrófilos
19. **Hombre 22 años desarrolla dolo abdominal marcado en el cuadrante inferior derecho. Se realiza una cirugía laparoscópica y el apéndice esta hinchado, eritematoso, parcialmente cubierto por exudado amarillento. Cuál de los siguientes mediadores químicos es causante del dolor que experimenta el paciente?**

a. Complementos C3b en inmunoglobulina G
b. IL-1 e TFN
c. **Prostaglandinas bradicininas**
d. Leucotrienos y HPT

20. **Paciente masculino de 65 años conocido portador de enfermedad renal crónica, con diálisis 3 veces por semana, acude a la consulta por estar con dolor en la mano izquierda. Se evidencia depósitos de calcio en las articulaciones carpometacarpianas. En la prueba de laboratorio muestra una calcemia de 15.4. (Valores normales ...)**
    a. **Calcificación metastásica**
    b. Calcificación idiopática
    c. Calcificación distrófica
    d. Calcificación senil

9. **Con respecto a la antracosis es correcto afirmar que:**
   a. Están relacionada a enfermedades pulmonares ocupacionales
   b. Puede inducir una reacción fibroblástica en los pulmones
   c. Se debe a inhalación de sustancias orgánicas e inorgánicas como la sílice y el carbón
   (d) El polvo de carbón es captado por macrófagos alveolares y transportados en ganglios linfáticos traqueobronquiales

10. **¿Cuál de los siguientes procesos se presenta más tempranamente en la inflamación aguda?**
   a. Adhesión neutrofílica
   (b) Incremento de la permeabilidad vascular
   c. Formación de edema inflamatorio
   d. Destrucción tisular

11. **Se realiza una toracocentesis de la cavidad pleural izquierda y se obtienen 500 ml de líquido. ¿Cuál de las siguientes características de este líquido indicaría con mayor probabilidad que se trata de un exudado?**
   (a) Alto contenido de proteínas
   b. Aspecto claro, seroso
   c. Recuento bajo de leucocitos
   d. Baja densidad

12. **Una niña de 4 años ha presentado numerosas infecciones por Staphylococcus aureus desde la lactancia. Las pruebas genéticas muestran un defecto causante de la ausencia de producción de β2-integrina. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que ocurra por deficiencia de β2-integrina?**
   a. Menor producción de radicales libres (ERO)
   (b) Adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio
   c. Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas
   d. Fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria

13. **Mujer de 29 años con una comunicación interventricular lleva 3 semanas con fiebre persistente de 38,6 °C y cefalea. Una TAC craneal muestra una lesión en anillo de 3 cm, de contenido licuado que capta contraste en el lóbulo parietal derecho del encéfalo. ¿Cuál de las siguientes acciones de las células inflamatorias es más probable que haya producido este hallazgo en la TAC?**
   a. Elaboración de óxido nítrico por los macrófagos
   b. Formación de inmunoglobulinas por linfocitos B
   (c) Liberación de enzimas lisosómicas por los neutrófilos
   d. Producción de interferón γ por linfocitos T

14. **Paciente femenina de 53 años sufre dolor abdominal de 2 semanas de evolución. N tiene fiebre; la zona superior del abdomen es ligeramente dolorosa, y se conserva los ruidos intestinales. Se realiza una biopsia y se observa una lesión duoden caracterizada por pérdida local de la superficie mucosa que contiene rest necróticos inflamados. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es m probable que esté presente?**
   a. Úlceras
   b. Absceso
   (c) Inflamación crónica
   d. Exudado purulento

SECCIÓN I: Cita con letra legible según corresponda (2p)

1. **2 tipos de calcificación patológica:**
   a. Distrofica
   b. Metastasica

2. **2 pasos del reclutamiento de leucocitos ocurridos en la luz vascular:**
   a. marginacion
   b. rodamiento

SECCIÓN II: Para cada una de las siguientes descripciones, escriba el hallazgo patológico más probable (3p)

Obs: para completar ten en cuenta las opciones que están en el cuadro de abajo.

3. Mujer sana de 73 años cae por las escaleras y se lesiona la cadera derecha. No hay fractura, pero la radiografía revela calcificación de las pequeñas arterias musculares laterales al útero
   ..... Calsificacion metastasica .....

4. Hombre de 35 años es golpeado en la pierna por un estante que cayó. La piel no está rota; 16 días después presenta una lesión de color amarillo-marrón producida por acumulación de una sustancia
   ..... Hemosiderina .....

5. Hombre de 25 años lleva todo el día trabajando en su jardín. En el examen físico se observa una ampolla por fricción en la piel de las manos
   ..... trasudado .....

• Hemosiderina	• Trasudado	• Calcificación metaplásica
• Aterosclerosis ulcerosa	• Bilirrubina	• Esclerosis medial calcificada
• Exudado purulento	• Lipofuscina	• Cuerpos de Psamoma

SECCIÓN III: Completa los enunciados correctamente y con letra legible (3p)

6. Las llamadas "Células de la Insuficiencia Cardiaca" corresponden a acúmulos de pigmento de..hemosiderina.....dentro de..macrofagos alveolares

7. Para confirmar el depósito de pigmento hemosiderínico en un paciente con anemia hemolítica se utiliza la tinción..... azul de prusia .....

SECCIÓN IV: Encierra en círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta (7p)

8. **¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la calcificación distrófica?**
   a. Es altamente sugestiva de una enfermedad renal crónica
   b. Se observa en pacientes con hiperparatiroidismo primario
   (c) Puede obs[illegible]e en placas ateromatosas complicadas
   Es fre[illegible]a intoxic[illegible]por vitamina D

UNIVERSIDAD CENTRAL

Nombre/s y Apellido/s: RG. / C.I. Firma del Estudiante: Nro. De lista: 15	Fecha: 26 / 11 / 2024 Turno: Mañana Semestre: 5° Sección: "C"
Materia: Anatomía Patológica I Docente: Eliana Chamorro	Carrera: Medicina Firma del Docente:
1-COLOQUE NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, N° DE DOCUMENTO Y N° DE LISTA. 2-LA PRUEBA ES INDIVIDUAL. 3-LA PRUEBA DEBE SER REALIZADA CON BOLIGRAFO (NEGRO O AZUL). 4- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CELULARES, RELOJES SMARTFOAM Y AURICULARES. DEBEN ESTAR APAGADOS. 6- USO DE UNIFORME REGLAMENTARIO. 5- BORRONES, ENMIENDAS Y DOBLE MARCACIONES ANULAN EL ÍTEM.	EVALUACIÓN PRUEBA PARCIAL TEÓRICA • TOTAL DE PUNTOS: 20% • PUNTAJE OBTENIDO:

SEGUNDA PRUEBA DE REGULARIZACIÓN

SECCIÓN I: Cita con letra legible según corresponda (3p)

1. **2 patologías que presentan una amiloidosis sistémica reactiva (secundaria):**
   a. Enf. de Crohn
   b. Colitis Ulcerosa

2. **2 mediadores químicos que causan aumento de la permeabilidad vascular:** LT C4, LT D4, LT E4
   a. histamina
   b. bradicinina

3. **2 fagocitos principales presentes en la reacción inflamatoria aguda:**
   a. Mastocitos, magrofagos
   b. neutrofilos

SECCIÓN II: Completa los enunciados correctamente y con letra legible (4p)

4. Paciente masculino de 65 años consulta por palpitaciones, el ecocardiograma informa aurícula izquierda agrandada con área valvular mitral de 1 cm (reducida), en donde se constata calcificación de tipo distrofica

5. La histamina es el principal mediador de la fase transitoria inmediata de la inflamación, causante de dilatación arteriolar y aumento de permeabilidad venular

6. Los cuerpos de Russell en las células plasmáticas del bazo de un hombre de 60 años están cargados de Inmunoglobulina

7. La pericarditis "en pan con mantequilla" es un ejemplo típico de inflamación aguda tipo Fibrinosa

Nombre/s y Apellido/s: RU. / C.I. Firma del Estudiante:	Fecha: 09 / 04 / 2024 Turno: Tarde Semestre: Quinto Sección: B
Materia: Anatomía Patológica I Docente: Eliana Chamorro Krauer	Carrera: Medicina Firma del Docente
1-COLOQUE NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. 2-LA PRUEBA ES INDIVIDUAL. 3- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CELULARES. DEBEN ESTAR APAGADOS.	EVALUACIÓN SEGUNDA PRUEBA RECUPERATORIA TEÓRICA • TOTAL DE PUNTOS: 15 • PUNTAJE OBTENIDO: ____

SEGUNDA PRUEBA RECUPERATORIA

SECCIÓN I: Encierra en círculo la letra que antecede a la respuesta correcta (6p)

1. **Paciente femenina de 25 años de edad que cocinando los alimentos en su casa sufre quemaduras de la mano con presencia posteriormente de ampollas a ese nivel. ¿Qué tipo de inflamación presentaría y cuál sería la característica de la extravasación?**
   a. Inflamación serosa; líquido con bajo contenido de células
   b. Inflamación fibrinosa; líquido con red eosinófila de fibrina
   c. Absceso; líquido con alto contenido de neutrófilos
   d. Inflamación supurativa; líquido con elevada concentración de proteínas
2. **Paciente de 20 años de edad que hace 2 días presenta fiebre elevada, dolor en fosas lumbares y ardor al orinar, en el examen de orina se encuentran leucocitos abundantes. En la respuesta inflamatoria, de los siguientes procesos, cuál se produce más tardíamente:**
   a. Liberación de histamina por degranulación de mastocitos
   b. Vasodilatación y estasis sanguínea
   c. Migración de monocitos
   d. Extravasación de líquido al espacio intersticial
3. **Paciente de 18 años de edad, femenina, con el antecedente de padecer de una fiebre reumática y que ahora presenta fiebre, soplo cardíaco y un roce pericárdico, se le diagnóstica una pericarditis "en pan y manteca", que es un ejemplo típico de inflamación de tipo:**
   a. Serosa
   b. Fibrinosa
   c. Supurativa
   d. Ulcerativa
4. **Paciente de 38 años de edad, masculino, fumador presenta dolor en epigastrio y acidez. Se le realiza una gastroscopia y se observa lesión ulcerada en el antro gástrico. ¿Qué mediadores químicos estarían implicados en la producción del dolor?**
   a. Anafilotoxinas
   b. Leucotrieno B4
   c. Opsoninas
   d. Bradicinina
5. **Se pueden observar células gigantes multinucleadas en todos los siguientes procesos inflamatorios. Excepto:**
   a. Tuberculosis
   b. Sarcoidosis
   c. Leishmaniasis
   d. Cuerpos extraños

6. **Paciente femenina de 40 años de edad que con antecedentes de una sinusitis aguda mal tratada hace un absceso cerebral como complicación. En la complicación inflamatoria observada generalmente no se observará:**
   a. Vasodilatación y vasocongestión
   b. Presencia de Leucotrieno B4
   c. Infiltrado linfoplasmocitario
   d. Residuos licuados de células necróticas

SECCIÓN II: Indica con (V) si el enunciado es verdadero o con una (F) si es falso. Justifica las respuestas falsas (4p)

7. La inhibición selectiva de la vía de la ciclo-oxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas (F...) Solamente los PG estarán afectados
8. El fenómeno de migración es un proceso de redistribución leucocitaria, por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo (F...) es la marginación
9. La forma en que inicialmente aumenta la permeabilidad vascular es por la contracción de células endoteliales, que determinan el incremento de los espacios interendoteliales (V...)
10. Cuando la sangre circula por el lecho capilar, se puede distinguir un flujo central y un flujo periférico. En condiciones normales, el flujo central contiene leucocitos y eritrocitos (V...)

SECCIÓN III: Cita con letra legible según corresponda (2p)

11. **3 manifestaciones locales de inflamación conocidos como signos cardinales:**
    a. tumor
    b. Rubor
    c. calor
12. **2 mediadores químicos de inflamación derivados del plasma:**
    a. Cinina Calatoxinas (C3a y C5a)
    b. enimas (bradicinina

SECCIÓN IV: Completa los enunciados correctamente (3p)

13. Las células gigantes multinucleadas derivan de la activación de: Macrofagos
14. El principal mediador en el edema producido por una reacción alérgica aguda es: Mastocitos
15. La presencia de un agente difícil de Madicar son condiciones para la formación de un granuloma.

N° DE LISTA:

RG. / C.I.

Curso: Tercero | Semestre: Quinto | Sección: "C" | Fecha: 21/02/2024

Firma del alumno:

Docente: Eliana Chamorro Krauer

Firma del docente:

Exámenes Finales: ☐ ORDINARIO ■ COMPLEMENTARIO ☐ EXTRAORDINARIO

Calificaciones solo para ser completado por el docente

A) 1ª Prueba de Proceso (5 ptos) B) 1ª parcial (15 ptos)		1-COLOQUE NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. 2-LA PRUEBA ES INDIVIDUAL. 3-LA PRUEBA DEBE SER REALIZADA CON BOLIGRAFO (NEGRO O AZUL) 4- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CELULARES. DEBEN ESTAR APAGADOS.	Escala de calificaciones: 01-59 = 1, 60-69 = 2, 70-80 = 3, 81-90 = 4, 91-100 = 5	Referencia calificaciones: A = 5 pts, B = 15 pts, C = 10 pts, D = 50 pts
A) 2ª Prueba de Proceso (5 ptos) B) 2ªparcial (15 ptos)				
C) Trabajo Practico (10ptos)				
D) Prueba Final (50 pts)				
l de puntos (100 pts)		Calificación final		

EXAMEN FINAL COMPLEMENTARIO

SECCIÓN I: Cita con letra legible según corresponda (2p cada enunciado)

1. Características morfológicas (microscópicas) de malignidad:
   a. Indiferenciado / Pleomorfismo | Pleomorfismo
   b. Mitosis Atipica / Anisonucleosis | Anisonucleosis
2. Anomalías por formación excesiva de componentes que participan en la reparación de los tejidos:
   a. Cicatrización Queloide | cicatrización queloide
   b. Cicatrización Hipertrofia | cicatrización hipertrofia
3. Enfermedades granulomatosas no necrosantes:
   a. Lepra | lepra
   b. Enfermedad de Crohn | Enf. de Crohn
4. Mediadores químicos denominados "anafilotoxinas":
   a. C3a | C3a
   b. C5a (quimiotatico) | C3a (quimiotactico)

SECCIÓN II: Completa con letra legible los siguientes enunciados (2p cada uno)

5. La calcificación....Metastasica metastasica se caracteriza por depósitos de calcio en tejidos viables como consecuencia de hipercalcemia secundaria a aumento de PTH hipercalcemia
6. ...Diferenciación.....es la magnitud en que las células neoplásicas se asemejan en su función y forma a las células correspondientes del parénquima sa

UNIVERSIDAD CENTRAL

7. La proliferación del epitelio glandular endometrial en una mujer embarazada es un ejemplo de ..... Hiperplasia Fisiologica ..... que ocurre como respuesta a estímulos hormonales hyperplasia Fisiologica

Pg 29 → 8. Las células Espitelioides epiteliodes .... presentan un citoplasma granular rosado con bordes celulares no diferenciados que corresponden a células derivadas de macrófagos activados

9. **SECCIÓN III: Parea las siguientes nomenclaturas con su definición correspondiente (2p)**
Obs: ten en cuenta que solo 2 son correctas, las demás quedarán en blanco (doble marcación anula el ítem)

a. Quiste dermoide
b. Hamartoma

→ Hamartoma

(B) Masas desorganizadas benignas de células propias del lugar afectado

(A) Teratoma quístico que se diferencia sobre todo de las líneas ectodérmicas

quistes dérmoide

(__) Presencia de tejido de aspecto normal en localización anormal

(__) Forma especializada de teratoma que contiene cartílago, tejido adiposo, glándulas intestinales y numerosos folículos tiroideos

(__) Proyección macroscópica visible sobre la superficie mucosa

SECCIÓN IV: Responde con letra legible los siguientes enunciados (2p c/enunciado)

10. Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o bien sufren lisis. ¿Qué componentes del plasma sanguíneo es más probable que facilite estos efectos?
.....Complemento..... complemento .....

11. Hombre de 43 años presenta tos crónica y fiebre de 1 mes de evolución. Una muestra de biopsia transbronquial revela infiltrados intersticiales con linfocitos, células plasmáticas y macrófagos activados. ¿Cuál de los mediadores químicos es más importante en la activación de los macrófagos?
.....Interferón γ..... Interferon γ .....

12. Mujer de 59 años se queja de dolor retroesternal con ardor leve después de las comidas durante los últimos 4 años. Se realiza una endoscopia y se toman biopsias de un área eritematosa de la mucosa esofágica inferior 3 cm por encima de la unión gastroesofágica, que muestra presencia de epitelio cilíndrico con células caliciformes. ¿Qué alteración de la mucosa está más probablemente representada?
.....Metaplasia intestinal..... Metaplasia Intestinal .....

13. Hombre de 67 años falleció debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. En la autopsia, el corazón pesa 580 g (normal 330 g), muestra hipertrofia del ventrículo izquierdo, área valvular aórtica disminuida. El hallazgo bioquímico sérico solicitado antes fue normal. ¿Qué tipo de calcificación patológica explica mejor la afectación de la válvula aórtica?
.....Calcificación distrófica.....

calcificación distrófica

SECCIÓN VI: Para cada una de las siguientes descripciones, escriba con letra legible la opción que corresponda (2p cada enunciado)
Obs: para completar ten en cuenta las opciones que están en el cuadro debajo de cada enunciado.

22. Hombre de 24 años con apendicitis aguda se somete a la extirpación quirúrgica del apéndice inflamado. La incisión se sutura. La microscopía óptica muestra un corte de la zona con tinción tricrómica: el colágeno abundante está teñido de azul. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía sería más probable observar esto?

4-5 días

• 1 día	• 4 – 5 días	• 1 mes

4-5 días (por causa do Tejido de granulación)

23. Un grupo de pacientes recibe un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). Los hombres adultos tenían artritis de pequeñas articulaciones. Refieren que el fármaco ha presentado ciertos efectos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que refiriera el grupo que recibió el fármaco?

• Numerosos episodios febriles	• Reducción del dolor articular	• Mayor tumefacción de los tobillos

Reducción del dolor

24. Hombre de 71 años tiene dificultad para orinar. Su retención urinaria provoca numerosos viajes al baño. En el tacto rectal la próstata está agrandada de forma difusa. ¿Cuál de los siguientes representa un cambio patológico que conduce al problema de este hombre?

• Displasia in situ	• Hipertrofia mioepitelial	• Hiperplasia glandular

Hiperplasia glandular

25. Una mujer de 48 años se somete a un examen físico de rutina. Se palpa una masa no dolorosa de 4 cm de diámetro en la mama derecha. La masa parece fijada a la pared torácica. Se palpa otra masa no dolorosa de 2 cm en la axila izquierda. Una radiografía de tórax revela múltiples nódulos de 0,5 a 2 cm en ambos pulmones. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones TNM indica mejor el estadio de su enfermedad?

• T1N1M0	• T2N1M0	• T4N1M1

T4N1M1 T4N1M1

T4 → Tamaño 4cm
N1 → Ganglios afectados
M1 → Tiene metastasis

SECCIÓN V: Encierra en círculo la letra que corresponda a la respuesta correcta (2p cada enunciado)

14. **En el proceso de curación, una incisión quirúrgica limpia no infectada es una lesión que se cura por:**
   a. Primera intensión
   b. Segunda intensión
   c. Regeneración epitelial
   d. Sin fibrosis

15. **Son características histológicas de la inflamación crónica:**
   a. Presencia de neutrófilos y macrófagos
   b. Aumento de permeabilidad vascular
   c. Vasodilatación y estasis sanguínea
   d. Proliferación de pequeños vasos sanguíneos

16. **Los cuerpos de Psamoma corresponden a un tipo de calcificación:**
   a. Displásica
   b. Distrófica
   c. Metastásica
   d. Atrófica

17. **Se realiza una biopsia cervical, cuyo estudio histológico muestra un carcinoma in situ con áreas de epitelio escamoso con formación de perlas córneas. El concepto de carcinoma in situ corresponde a una lesión que se caracteriza por:**
   a. Ausencia de atipia marcada
   b. Baja incidencia de metástasis
   c. Membrana basal intacta
   d. Crecimiento desordenado en todo el espesor epitelial

18. **De acuerdo a la capacidad de proliferación, las células de la médula ósea se clasifican como:**
   a. Lábiles
   b. Estables
   c. Permanentes
   d. Transitorios

19. **Una masa sólida en la pared uterina se corresponde con un leiomiosarcoma bien diferenciado. Ante este dato, podemos afirmar que se trata de una masa:**
   a. Maligna, epitelial, no encapsulada
   b. Benigna, derivada de varias capas germinales
   c. Maligna, de origen mesenquimático
   d. Benigna, de crecimiento lento, encapsulado

20. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes; marca la alternativa correcta:**
   a. Leucotrieno B4, aumento de permeabilidad vascular
   b. C5b-9, proceso de lisis celular
   c. Prostaciclina, vasoconstrictor
   d. IL-6, quimiotáctico

21. **¿Qué cambios podríamos observar en un corazón hipertrofiado?**
   a. Aumento del peso del órgano debido a nuevas células
   b. Mayor tamaño celular debido a la acumulación de líquido intracitoplasmático
   c. Aumento de proteínas contráctiles intracitoplasmáticas
   d. Menor consumo de oxígeno para realizar el mismo trabajo que el corazón normal

1. Características morfológicas (microscopica) de malignidad:
R: Nucleo hipercromatico y figuras mitóticas atípicas
2. Anomalías por formación excesiva de componentes que participan en la reparación de los tejidos;
R: cicatrices hipertróficas y cicatrices queloides
3. Enfermedades granulomatosas no necrosantes;
R: Sarcoidosis , Enfermedad de Crohn y Lepra
4. Enfermedades Granulomatosa Necrosante:
R:Tuberculose y Siflis
5. Mediadores químicos denominados "anafilotoxinas";
R C3a y C5a
6. La calcificación **metastásica** se caracteriza por depósitos de calcio entejidos variables como consecuencia de hipercalcemia secundária a un aumento de PTH.
7. **Diferenciación** es la magnitud es que las células neoplásicas se asemejan en su función y forma a las células correspondidas del parénquima sano.
8- La falta de Diferenciacion se conoce **Anaplasia.**
9. La proliferación del epitelio glandular endometrial es una mujer embarazada es un ejemplo de **hiperplasia fisiológica** que ocurre como respuesta a estímulos hormonales.
10-Las células **epiteiloides** presentan un citoplasma granular rosado con bordes celulares no diferenciados que corresponden a células derivadas de **macrofagos activados**.
11-SECCIÓN III: Parea las siguientes nomenclaturas con su definición correspondiente; Obs: tem em cuenta que solo 2 son correctas ,las demas quedaran em blanco.

A) Quiste dermoide. B) Hamartoma

(B) Masas desorganizadas benignas de células propias del lugar afectado.

(Hamartoma: masas desorganizadas (benignas), de células propias del lugar afectado (aberraciones cromosómicas clonales); hamartoma pulmona)

(A) Teratoma quístico que se diferencia sobre todo de las líneas ectodérmicas

Teratoma quístico del ovario: se diferencia sobre todo de las líneas ectodérmicas (tumor quístico tapizado por piel y lleno de pelos, glándulas sebáceas y estructuras dentarias) "QUISTE DERMOIDE"

(X) Presencia de tejido de aspecto normal en localización anormal.

(X) Forma especializada de teratoma que contiene cartílago, tejido adiposo, glándulas intestinales y numerosos folículos tiroideos. Se presenta en el hamartoma pulmonar

(X) Proyección macroscópica visible sobre la superficie mucosa.

12. Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o bien sufren lisis. ¿Qué componentes del plasma sanguíneo es más probable que facilite estos efectos?

R:Complemento

13. Hombre de 43 años presenta tos crónica y fiebre de 1 mes de evolución. Una muestra de biopsia transbronquial revela infiltrados intersticiales con linfocitos, células plasmáticas y macrófagos activados. ¿Cuál de los mediadores químicos es más importante en la activación de los macrófagos?

R: Interferón Y

14-Mujer de 59 años se queja de dolor retroesternal con ardor leve después de las comidas durante los últimos 4 años. Se realiza una endoscopia y se toman biopsias de un área eritematosa de la mucosa esofágica inferior 3 cm por encima de la unión gastroesofágica, que muestra presencia de epitelio cilíndrico con células caliciformes. ¿Qué alteración de la mucosa está más probablemente representada?

R: Metaplasia intestinal (esófago de Barret) .

15.En el proceso de curación, una incisión quirúrgica limpia no infectada, es una lesión que se cura por;

a) Primera intención

b) Segunda intención

c) Regeneración epitelial

d) Sin fibrosis

16. Son características biológicas de la inflamación crónica;

a) Presencia de neutrófilos y macrófagos

b) Aumento de la permeabilidad vascular

c) Vasodilatación y estasis sanguínea

d) Proliferación de pequeños vasos sanguíneos

17-Los cuerpos de psamona corresponden a un tipo de calcificacion;

a) Displasica

b) Distrofica

c) Metaplasica

d) Atrofica

18. Se realiza una biopsia cervical, cuyo estudio histologico muestra un carcinoma in situ con áreas de epitelio escamoso con formación de perlas córneas. El concepto de carcinoma in situ corresponde a una lesión

que se caracteriza por;
a) Ausencia de atipia Marcada
b) Baja incidencia de metástases
c) Membrana basal intacta
d) Crecimiento Desordenado en todo espesor epitelial
19-. De acuerdo a la capacidad de proliferación, las células de la médula ósea se clasifican como:
a) Lábiles
b) Estables
c) permanentes
d) Transitorios
20-Una masa sólida en la pared uterina se corresponde con un **leiomiosarcoma** bien diferenciado. Ante este dato, podemos afirmar que se trata de una masa:
a) Maligna, epitelial, no encapsulada
b) Benigna, derivada de varias capas germinales
c) Maligna, de origen mesenquimático
d) Benigna, de crecimiento lento, encapsulado
Sarcoma= maligno, tiene que ser mesenquimatoso, se for epitelial, seria carcinoma
21. Teniendo en cuenta los siguientes mediadores químicos y sus efectos correspondientes; marca la alternativa correcta:
a) Leucotrieno B4, aumento de permeabilidad vascular
b) C5b-9, proceso de lisis celular
c) Prostaciclina, vasoconstrictor
d) IL-6, quimiotáctico
22-¿Qué cambios podríamos observar en un corazón hipertrofiado?
a) Aumento del peso del órgano debido a nuevas células
b) Mayor tamaño celular debido a la acumulación de líquido intracitoplasmático
c) Aumento de proteínas contráctiles

intracitoplasmáticas

d) Menor consumo de oxígeno para realizar el mismo trabajo que el corazón normal

22. Hombre de 24 años con apendicitis aguda se someto a la extirpación quirúrgica del apéndice inflamado. La incisión se sutura. La microscopía óptica muestra un corte de la zona con tinción tricrómica: el colágeno abundante está teñido de azul, ¿cuánto tiempo después de la cirugía sería más probable observar esto?

A) 1 dia

B) 4-5 dias

23-Hombre de 71 años tiene dificultad para orinar. Su retención urinaria provoca numerosos viajes al baño. En el tacto rectal la próstata está agrandada de forma difusa. ¿Cuál de los siguientes representa un cambio patológico que conduce al problema de este hombre?

A) Displasia in situ

B) Hipertrofia mioepitelial

C) Hiperplasia glandular

25. Una mujer de 48 años se somete a un examen físico de rutina. Se palpa una masa no dolorosa de 4 cm de diámetro en la mama derecha. La masa parece fijada a la pared torácica. Se palpa otra masa no dolorosa de 2 cm en la axila izquierda. Una radiografía de tórax revela múltiples nódulos de 0,5 a 2 cm en ambos pulmones. ¿cuál de las siguientes clasificaciones TNM indica mejor el estadio de su enfermedad?

a) T1N1M0

b) T2N1M0

c) T4N1M1

T4 por aumentar de tamanho 2cm para 4cm

N1 por afectacion de gânglios en las axilas

M1 por haber metastasis (pulmón, nódulos en mamas)

26. Cuales son los criterios usa para la estadificación de tumores;
R: Tamaño de la lesión primaria
Propagación en ganglios linfáticos
Presencia o ausencia de metástases
27. Acúmulo abundante de colágeno em neoplasia
Desmoplasia
28. Citar dos características de la inflamacion crónica;
R: Infiltración por células mononucleadas (Macrofagos , Linfocitos e Celulas Plasmaticas)
Intentos de curación (Angiogenia – proliferacion de pequenos vasos)
29. fases del trajeto leucocitario que acontece em la luz vascular;
R: Marginacion, rodamiento, adhesión
30. Quales son los mediadores químicos derivados de célula que hace vasodilatacion
R: Histamina y Prostaglandina
BRADICININA NO ES DERIVADA DE CELULA !!!!!
31-Cite las diferencias del tejido de granulacion y cicatriz;
TEJ DE GRANULACION: angiogenesis (muchos vasos) / colageno tipo 3 / fibroblastos activos
CICATRIZACION: desvascularizacion / colageno tipo 1 / fibroblastos inactivos
32-Cual es el mediador en reacciones alérgicas;
R: Histamina
32. tipo de disseminacion metastasica de um tumor pulmonar;
R: Es la diseminacion hematógena
33-Proceso de redistribución leucocitaria. Los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial **Marginacion**
33-Anomalias causadas por deformidades da cicatrização:

R: úceras y dehicencia o rotura de la herida

34-Dos processos de reclutamiento de leucócitos que acontece en el tejido:

R:transmigracion y quimiotaxis

35- Caso clinico: Ulceras e abcesos são cicatrizes de?

2° intencion

36-La necrosis observada en trastorno de una infección por bacteria piógena es un ejemplo de: **Necrosis licuefactiva**

Turma D

P1

Chamorro

1º PARCIAL ANATOMIA PATOLÓGICA I

1) Dos enzimas involucradas em el proceso de muerte por apoptosis.

Caspasas
Citocromo C (anulado)
Endonucleasa

caspasas
endonucleasas

2) Padrones de necrosis que presentan digestión enzimática. (heterolisis)

Necrosis licuefactiva ✓
Necrosis grasa ✓
Necrosis gangrenosas húmeda ✓
Necrosis caseosa ✓

n. licuefactiva
n. graso
n. gangrenoso húmido
n. caseoso

0.09 : 10.00

coagulativa ou gangrena seca?

fibrinoide no

3) Dos componentes principales de las placas arteriosclerósicas.

Macrófagos
Células musculares lisas
Capsula fibrosa.
Colesterol: LDL
Hendiduras de colesterol (hendiduras de cristales)
Células espumosas: Linfocitos T, macrófagos y células musculares lisas.

macrofagos
Capsula
Fibrose

macrofagos
capsulas fibrosa
celulas espumosas

4) Picnosis es un cambio nuclear caracterizado por ..... Nuclear y aumento de basofilia (cromatina se condensa en una masa basófila sólida).

Retracción.

Retracción

- picnosis - retracción, ↑ basofilia (fag con + q a cromatina se condensa)
- cariorexis - fragmentação
- cariólise - dissolução

5) En una hepatectomía parcial, se inicia un estímulo por factores de crecimiento, lo que conduce a un aumento de tamaño del hígado. Proceso adaptativo que corresponde a:

Hiperplasia fisiológica compensatoria.
Hiperplasia compensatoria.

hiperplasia fisiologica compensatoria

6) La tinción ..... Que da una coloración azul negro a depósito intracelular excesivo de triglicéridos.

Sudan Negro B

Oxi

Sudan negro B

Mas é azul preto e pinta cabo vermelho

7) El aumento de la glicolisis anaeróbica produce acumulación de ácido láctico, lo que reduce el ph intracelular. ¿o que genera esto?

Condensación de la cromatina nuclear.

a principal coisa que ocorre com ao ph intracelular é = condensação da cromatina

condensación de la cromatina nuclear

8) Complete 00:36:30

Metaplasia intestinal: esofago

donde en próximo metaplasia intestinal? ESÔFAGO

EPE não CSCC

epitelio inicial: epitelio plano estratificado no queratinizado.

epitelio final: epitelio cilíndrico simples con células caliciformes.

se tem é pq é gástrico ou intestinal

factor de riesgo asociado: reflujo gastro-esofágico.

audio 06/09 ± metade audio

RGE

Metaplasia escamosa:

Epitelio inicial: epitelio respiratorio.

EPE no **epitelio final:** epitelio plano estratificado no queratinizado.

factor de riesgo asociado: tabaquismo.

Deficiencias de vitamina a

Vit A

Para cada una de las siguientes descripciones, escriba lo que mejor corresponda a cada situação.

não são perguntas diretas

Falla de bomba Na+ / K+	Lipasas pancreáticas activas	Síntesis de proteínas disminuidas
Necroptosis receptores de morte e não mitocondria	Presencia de espacios quísticos	Colesterol LDL bajo
Gangrena Seca	Aumento de la mitosis celular	Caspasas iniciadoras

→ espaços quísticos cerebro SNC

dps que esteja relacionado com a questão

9) **La muerte causa por el aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa que permite la activación de sustancias citosólicas** .....

Caspasas iniciadoras

Caspasas iniciadoras

10) **Mujer con 75 años sufrió perdida de conocimiento. No puede hablar ni comer con el brazo derecho a causa de una oclusión de la arteria cerebral media izquierda** .....

é cérebro

Presencia de espacio quísticos

Presencia de espacio quistico

Se houve isquemia (houve necrose liquefativa (perda massa cerebral)

11) **Hombre de 65 años tiene dificultad para orinar. Su retención orinaría provoca numerosos viajes al baño. En el tacto rectal, la próstata esta agrandada de forma difusa .....**

Aumento de la mitosis celular. hiperplasia prostatica benigna

hiperplasia prostática benigna

12) **Al microscopio óptico en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica** lembrar que é M.óptico

a) Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma de las células esteatose
b) Presencia de masas de fosfolípidos llamadas figuras de mielina. necrose
c) Formación de vesículas en las membranas plasmáticas. apoptose
d) **Aumento de la acidófila por medio de ARN citoplasmático**

13) **LOS TEJIDOS QUE TIENE CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HIPERPLÁSICO SE CLASIFICA COMO LABILES, CORRESPONDE A:**

LEP
IPE
IRN
(OO)

a) Músculo esquelético, túbulos renales y acinos pancreáticos.
b) **Células de la médula ósea, ganglios linfáticos y epidermis.**
c) Tejido de granulación, cerebro, y medula suprarrenal.
d) Folículos tiroideos, células endoteliales y hepatocitos.

14) **QUE TRANSTORNO CLÍNICO SE ASOCIA CON UNA APOPTOSIS FISIOLÓGICA**

a) Infección en el pie derecho en un paciente diabético.
b) Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson
c) Verrugas cutáneas en pacientes con infección por papiloma virus.
d) **Eliminación de las membranas interdigitales para formación de los dedos.**

15) **¿CUAL DE LOS SEGUIENTES CORRESPONDE A UNA COMPLICACIÓN DE LAS PLACAS ATEROMATOSAS?**

a) Taponamiento não estudamos isso ainda
b) Rotura del músculo papilar
c) Hemorragia pericárdica
d) **Formación de aneurismas**

16) **¿CUAL DE LAS SEGUIENTES COLOCARIONES SERIA LA PREFERIBLE PARA EVIDENCIAS ADECUADAMENTE LA PRESENCIA DE ACUMULACIONES INTRACELULARES EN LA GLUCOGENOSIS TIPO IV?** PAS

tinção para glucogeno

a) Hematoxilina & Eosina

b) Tricrómica de Mallory

c) **Ácido Periódico de Shift**

d) Aceite Rojo O

17) **EL ENGROSAMIENTO DE LA PARED VENTRICULAR CARDIACA EN UN PACIENTE CON VALVULOPATIA AORTICA ES UN EJEMPLO DE ..... Y OCURRE POR .....**

a) **Hipertrofia patológica, aumento de volumen celular**

b) Hiperplasia patológica, aumento de volumen celular

c) Hipertrofia fisiológica, aumento de número de células

d) Hiperplasia compensatoria, aumento del número de células.

18) **SE REALIZA UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR RIESGO PREDISPONENTES A CAMBIOS CELULARES A LOS TEJIDOS EN ALGUNAS PERSONAS SE PRODUCE METAPLASIA EPITELIAL. EN CUL DE LAS SEGUINTES SITUACIONES ES MÁS PROVABLE QUE SE PRODUZCA EL PROCESO DE METAPLASIA:**

a) Bronceado de la piel ante exposición al sol.

b) **Deficiencia de vitamina A**

c) Infarto agudo de miocardio

d) Infección urinaria por agrandamiento de la próstata.

19) **HOMBRE 55 AÑOS QUE TIENE DM MAL CONTROLADA HACE 15 AÑOS, APRESENTO UNA EXTENCIA COLORACIÓN NEGRA DE LA PIEL Y TEJIDO BLANDOS DEL PIE DERECHO CON AREAS DE EXUDADO AMARILLENTO. SE CULTIVA STAFILO COCUS AUREOS Y SE REALIZA A AMPUTACIÓN. ¿CUAL DE LA SEGUIENTES ANOMALIAS PATOLÓGICAS TIENE MÁS PROBABILIDAD DE MOSTRAR LA MUESTRA RECEBIDA DEL LABORATORIO?**

a) Apoptosis patológica

b) Infarto rojo

c) **Gangrena húmeda**

d) Necrosis caseosa.

20) **UN TECNICO DE RADIO X ASSISTE AL HOSPITAL PARA UN CHEQUEO DE RUTINA. EL MÉDICO DECIDE QUE DEBE SER SEPARADO DE PUESTO DE TRABAJO POR 6 MESES PUES SU EXAMEN**

FISICO Y COMPLEMENTARIO INDICA QUE HÁ RECIBIDO UN EXCESO DE RADIACIÓN. QUE EFECTO CAUSEAR LOS LADICALES LIBRE EN LAS CELULAS

a) Activación de fosfolipasas y proteasas

b) Falla de bomba Na+/K+

c) Aumento de ácido láctico

d) Mal plegamiento de proteínas

VÍRUS é apoptosis
após proceso (tto) hipoxia tisular com

Para cada una de las siguientes descripciones, escriba lo que mejor corresponda a cada situación.

Falla de bomba Na+ / K+	Lipasas pancreáticas activas	Síntesis de proteínas disminuidas
Necroptosis	Presencia de espacios quísticos	Colesterol LDL bajo
Gangrena Seca	Aumento de la mitosis celular	Caspasas iniciadoras

9) La muerte causa por el aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa que permite la activación de sustancias citosólicas .....

Caspasas iniciadoras

10) Mujer con 75 años sufrió perdida de conocimiento. No puede hablar ni comer con el brazo derecho a causa de una oclusión de la arteria cerebral media izquierda .....

Presencia de espacio quísticos

11) Hombre de 65 años tiene dificultad para orinar. Su retención orinaría provoca numerosos viajes al baño. En el tacto rectal, la próstata esta agrandada de forma difusa .....

Aumento de la mitosis celular.

1º PARCIAL ANATOMIA PATOLÓGICA I

1) **Dos enzimas involucradas em el proceso de muerte por apoptosis.**

   Caspasas

   Citocromo C (anulado)

   Endonucleasa

2) **Padrones de necrosis que presentan digestión enzimática.**

   Necrosis licuefactiva

   Necrosis grasa

   Necrosis gangrenosas húmeda

   Necrosis caseosa

3) **Dos componentes principales de las placas arteriosclerósicas.**

   Macrófagos

   Células musculares lisas

   Capsula fibrosa.

   Colesterol: LDL

   Hendiduras de colesterol (hendiduras de cristales)

   Células espumosas: Linfocitos T, macrófagos y células musculares lisas.

4) **Picnosis es un cambio nuclear caracterizado por ..... Nuclear y aumento de basofilia (cromatina se condensa en una masa basófila sólida).**

   Retracción.

5) **En una hepatectomía parcial, se inicia un estímulo por factores de crecimiento, lo que conduce a un aumento de tamaño del hígado. Proceso adaptativo que corresponde a:**

   Hiperplasia fisiológica compensatoria.

   Hiperplasia compensatoria.

6) **La tinción ..... Que da una coloración azul negro a depósito intracelular excesivo de triglicéridos.**

   Sudan Negro B

7) **El aumento de la glicolisis anaeróbica produce acumulación de ácido láctico, lo que reduce el ph intracelular. ¿o que genera esto?**

Condensación de la cromatina nuclear.

8) **Complete**

Metaplasia intestinal:

epitelio inicial: epitelio plano estratificado no queratinizado.

epitelio final: epitelio cilíndrico simples con células caliciformes.

factor de riesgo asociado: reflujo gastro-esofágico.

Metaplasia escamosa:

Epitelio inicial: epitelio respiratorio.

epitelio final: epitelio plano estratificado no queratinizado.

factor de riesgo asociado: tabaquismo.

Deficiencias de vitamina a

Para cada una de las siguientes descripciones, escriba lo que mejor corresponda a cada situación.

Falla de bomba Na+ / K+	Lipasas pancreáticas activas	Síntesis de proteínas disminuidas
Necroptosis	Presencia de espacios quísticos	Colesterol LDL bajo
Gangrena Seca	Aumento de la mitosis celular	Caspasas iniciadoras

9) **La muerte causa por el aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa que permite la activación de sustancias citosólicas .....**

Caspasas iniciadoras

10) **Mujer con 75 años sufrió perdida de conocimiento. No puede hablar ni comer con el brazo derecho a causa de una oclusión de la arteria cerebral media izquierda .....**

Presencia de espacio quísticos

11) Hombre de 65 años tiene dificultad para orinar. Su retención orinaría provoca numerosos viajes al baño. En el tacto rectal, la próstata esta agrandada de forma difusa .....

Aumento de la mitosis celular.

12) Al microscopio óptico en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica

a) Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma de las células
b) Presencia de masas de fosfolípidos llamadas figuras de mielina.
c) Formación de vesículas en las membranas plasmáticas.
d) Aumento de la acidófila por medio de ARN citoplasmático

13) LOS TEJIDOS QUE TIENE CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HIPERPLÁSICO SE CLASIFICA COMO LABILES, CORRESPONDE A:

a) Músculo esquelético, túbulos renales y acinos pancreáticos.
b) Células de la médula ósea, ganglios linfáticos y epidermis.
c) Tejido de granulación, cerebro, y medula suprarrenal.
d) Folículos tiroideos, células endoteliales y hepatocitos.

14) QUE TRANSTORNO CLÍNICO SE ASOCIA CON UNA APOPTOSIS FISIOLÓGICA

a) Infección en el pie derecho en un paciente diabético.
b) Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson
c) Verrugas cutáneas en pacientes con infección por papiloma virus.
d) Eliminación de las membranas interdigitales para formación de los dedos.

15) ¿CUAL DE LOS SEGUIENTES CORRESPONDE A UNA COMPLICACIÓN DE LAS PLACAS ATEROMATOSAS?

a) Taponamiento
b) Rotura del músculo papilar
c) Hemorragia pericárdica
d) Formación de aneurismas

16) ¿CUAL DE LAS SEGUIENTES COLOCARIONES SERIA LA PREFERIBLE PARA EVIDENCIAS ADECUADAMENTE LA PRESENCIA DE ACUMULACIONES INTRACELULARES EN LA GLUCOGENOSIS TIPO IV?

a) Hematoxilina & Eosina
b) Tricrómica de Mallory
c) Ácido Periódico de Shift
d) Aceite Rojo O

17) EL ENGROSAMIENTO DE LA PARED VENTRICULAR CARDIACA EN UN PACIENTE CON VALVULOPATIA AORTICA ES UN EJEMPLO DE ..... Y OCURRE POR .....:

a) Hipertrofia patológica, aumento de volumen celular
b) Hiperplasia patológica, aumento de volumen celular
c) Hipertrofia fisiológica, aumento de número de células
d) Hiperplasia compensatoria, aumento del número de células.

18) SE REALIZA UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR RIESGO PREDISPONENTES A CAMBIOS CELULARES A LOS TEJIDOS EN ALGUNAS PERSONAS SE PRODUCE METAPLASIA EPITELIAL. EN CUL DE LAS SEGUINTES SITUACIONES ES MÁS PROVABLE QUE SE PRODUZCA EL PROCESO DE METAPLASIA:

a) Bronceado de la piel ante exposición al sol.
b) Deficiencia de vitamina A
c) Infarto agudo de miocardio
d) Infección urinaria por agrandamiento de la próstata.

19) HOMBRE 55 AÑOS QUE TIENE DM MAL CONTROLADA HACE 15 AÑOS, APRESENTO UNA EXTENCIA COLORACIÓN NEGRA DE LA PIEL Y TEJIDO BLANDOS DEL PIE DERECHO CON AREAS DE EXUDADO AMARILLENTO. SE CULTIVA STAFILO COCUS AUREOS Y SE REALIZA A AMPUTACIÓN. ¿CUAL DE LA SEGUIENTES ANOMALIAS PATOLÓGICAS TIENE MÁS PROBABILIDAD DE MOSTRAR LA MUESTRA RECEBIDA DEL LABORATORIO?

a) Apoptosis patológica
b) Infarto rojo
c) Gangrena húmeda
d) Necrosis caseosa.

20) UN TECNICO DE RADIO X ASSISTE AL HOSPITAL PARA UN CHEQUEO DE RUTINA. EL MÉDICO DECIDE QUE DEBE SER SEPARADO DE PUESTO DE TRABAJO POR 6 MESES PUES SU EXAMEN

FISICO Y COMPLEMENTARIO INDICA QUE HÁ RECIBIDO UN EXCESO DE RADIACIÓN. QUE EFECTO CAUSEAR LOS LADICALES LIBRE EN LAS CELULAS

a) Activación de fosfolipasas y proteasas

b) Falla de bomba Na+/K+

c) Aumento de ácido láctico

d) Mal plegamiento de proteínas

1º PARCIAL ANATOPATO I Recuperatorio

Sexo masculino	Necrosis Fibrinoide	Necroptosis
Aumento de colesterol	Digestión enzimática	Colestasis
Displasia escamosa	Aumento da mitosis celular	Metaplasia intestinal

1. **Vesícula biliar con padrón en fresa, muestra evidencias microscópicamente con numerosos jabones espumosos en la lámina propia.**

   Aumento de colesterol

2. **Paciente 24 años presenta dolor en el hipogástrico después de ingerir comidas grasosas. Una muestra de biopsia de su esófago muestra epitelio cilíndrico con células caliciformes.**

   Metaplasia intestinal

3. **Mujer 30 años fallece ... eritematoso sistémico, enfermedad donde a reacciones inflamatorias de etiología inmunológica que ha afectado las paredes de los vasos sanguíneos.**

   Necrosis fibrinoide

4. **Dos factores de riesgo no modificables para el desarrollo de placas ateromatosas**

   a) Sexo masculino
   b) Edad avanzada
   c) Reacciones genéticas
   d) Antecedentes familiares

5. **Dos tinciones específicas para evidenciar las acumulaciones intracelulares de glucógeno**

   a) PAS
   b) Carmin de Best

6. **Dos cambios nucleares que se encuentran en una célula necrótica.**

   (No se acepta descripciones)

   a) Picnosis
   b) Cariorrexis
   c) Cariólisis

7. **Los infartos que macroscópicamente presentan una forma de cuña se clasifica según su color corresponde histológicamente como una necrosis** Coagulativa

8. **Las células tienen mecanismos por el cual repara el daño en lo ADN, aunque cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte que corresponde a** Apoptosis

9. **Hombre de 70 años presenta atrofia parda en el corazón, en la autopsia el corazón pesa solo 250g. Microscópicamente se ve que las fibras miocárdicas muestran cantidad excesivas de pigmento** Lipofucsina

10. Se los límites de la respuesta adaptiva se exceden, se inicia una serie de episodios que se conoce como Lesión Celular

11. Al microscopio electrónico, a un padrón de lesión celular reversible, se podrá observar:

a) Rotura de la membrana plasmática

b) Dilatación masiva de la mitocondria

c) Presencia de figuras de mielina

d) Aumento de acidofilia

12. El estrés oxidativo provoca un aumento la peroxidación de líquidos intracelulares. La reducción de la siguiente sustancia dentro de lo citoplasma empeora el daño celular por esto mecanismo

a) Glutatión peroxidasa

b) Fosfolipasas

c) Citocromo C

d) Endonucleasa

13. Los tejidos que tiene la capacidad de crecimiento hiperplásico y se clasifican como estables corresponde a:

a) Músculo esquelético, ácinos pancreáticos

b) Músculo liso, hepatocitos

c) Células de la médula ósea, epidermis

d) Tejido de granulación, cerebro

14. ¿Cuál de los siguientes trastornos clínicos se asocian a necrosis licuefactiva?

a) Infecciones agudas por el virus de la hepatitis B

b) Lesión vascular en el pie derecho de un paciente diabético

c) Infarto del miocardio en paciente con ateroesclerosis.

d) Infarto cerebral o trombosis.

15. ¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos es más probable que atente a una necrosis tubular aguda?

a) Aumento de basofilia

b) Perdida de microvellosidades

c) Tumefacción de las mitocondrias

d) Núcleos que sufren fragmentación

16. En el mecanismo de edema celular se suele encontrar inicialmente:

a) Acumulación de potasio intracitoplasmático

b) Aumento del pH intracelular

c) **Disminución de la fosforilación oxidativa**

d) Activación de glucolisis anaeróbica

17. **Una mujer de 69 años ha sufrido ... transitorias en los últimos 3 meses. En la ... derecha se reseca una placa ateromatosa, aspecto firme, color amarillo oscuro a simple vista. Microscópicamente, que sustancias podemos encuentra con abundancia:**

a) Triglicéridos e lipoproteínas

b) Colesterol y esteres de colesterol

c) Fosfolípidos y ácidos grasos libres

d) Triglicéridos y ...

18. **Una mujer de 22 años esta embarazada. En la ecografía fetal de 13 semanas muestra que el útero mide 7x4x3cm. En el parto en término, el útero mide 34x18x12cm. ¿Cuál de los siguientes procesos celulares ha contribuido para el incremento de tamaño del útero?**

a) Hipertrofia del músculo liso uterino

b) Hipertrofia del estroma endometrial

c) Hiperplasia del endotelio vascular

d) Hiperplasia atípica del endometrio.

19. **Hombre 73 años consulta por dolor abdominal en el examen muestra el hígado dos veces el tamaño normal, amarillo de superficie lisa. Microscópicamente se muestra numerosas vacuolas transparentes en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la posible causa de las alteraciones de lo paciente?**

a) Infección por el virus de hepatitis

b) Alimentación rica en fibras

c) Consumo de alcohol

d) Anemia hemolítica

20. **Mujer de 78 años perdió el conocimiento de repiente, no podría hablar ni mover el brazo derecho. Ha dos meses una tomografía mostro una gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya obtenido lugar en el encéfalo?**

a) Necrosis gangrenosa con formación de cavitaciones

b) Infiltrados neutrofílicos con restos licuados

c) Lesión granulomatosa que presenta células multinucleadas

d) Granuloma que presentan centralmente depósitos de inmunocomplejos.

1º PARCIAL ANATOPATO I Recuperación

Sexo masculino	Necrosis Fibrinoide	Necroptosis
Aumento de colesterol	Digestión enzimática	Colestasis
Displasia escamosa	Aumento da mitosis celular	Metaplasia intestinal

1. **Vesícula biliar con padrón en fresa, muestra evidencias microscópicamente con numerosos jabones espumosos en la lámina propia.**

   Aumento de colesterol

2. **Paciente 24 años presenta dolor en el hipogástrico después de ingerir comidas grasosas. Una muestra de biopsia de su esófago muestra epitelio cilíndrico con células caliciformes.**

   Metaplasia intestinal

3. **Mujer 30 años fallece ... eritematoso sistémico, enfermedad donde a reacciones inflamatorias de etiología inmunológica que ha afectado las paredes de los vasos sanguíneos.**

   Necrosis fibrinoide

4. **Dos factores de riesgo no modificables para el desarrollo de placas ateromatosas**

   a) Sexo masculino
   b) Edad avanzada
   c) Reacciones genéticas
   d) Antecedentes familiares

5. **Dos tinciones específicas para evidenciar las acumulaciones intracelulares de glucógeno**

   a) PAS
   b) Carmin de Best

6. **Dos cambios nucleares que se encuentran en una célula necrótica.**

   (No se acepta descripciones)

   a) Picnosis
   b) Cariorrexis
   c) Cariólisis

7. **Los infartos que macroscópicamente presentan una forma de cuña se clasifica según su color corresponde histológicamente como una necrosis** Coagulativa

8. **Las células tienen mecanismos por el cual repara el daño en lo ADN, aunque cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte que corresponde a** Apoptosis

9. **Hombre de 70 años presenta atrofia parda en el corazón, en la autopsia el corazón pesa solo 250g. Microscópicamente se ve que las fibras miocárdicas muestran cantidad excesivas de pigmento** Lipofucsina

10. **Se los límites de la respuesta adaptiva se exceden, se inicia una serie de episodios que se conoce como** Lesión Celular
11. **Al microscopio electrónico, a un padrón de lesión celular reversible, se podrá observar:**
    a) Rotura de la membrana plasmática
    b) Dilatación masiva de la mitocondria
    c) Presencia de figuras de mielina
    d) Aumento de acidofilia
12. **El estrés oxidativo provoca un aumento la peroxidación de líquidos intracelulares. La reducción de la siguiente sustancia dentro de lo citoplasma empeora el daño celular por esto mecanismo**
    a) Glutatión peroxidasa
    b) Fosfolipasas
    c) Citocromo C
    d) Endonucleasa
13. **Los tejidos que tiene la capacidad de crecimiento hiperplásico y se clasifican como estables corresponde a:**
    a) Músculo esquelético, ácinos pancreáticos
    b) Músculo liso, hepatocitos
    c) Células de la médula ósea, epidermis
    d) Tejido de granulación, cerebro
14. **¿Cuál de los siguientes trastornos clínicos se asocian a necrosis licuefactiva?**
    a) Infecciones agudas por el virus de la hepatitis B
    b) Lesión vascular en el pie derecho de un paciente diabético
    c) Infarto del miocardio en paciente con ateroesclerosis.
    d) Infarto cerebral o trombosis.
15. **¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos es más probable que atente a una necrosis tubular aguda?**
    a) Aumento de basofilia
    b) Perdida de microvellosidades
    c) Tumefacción de las mitocondrias
    d) Núcleos que sufren fragmentación
16. **En el mecanismo de edema celular se suele encontrar inicialmente:**
    a) Acumulación de potasio intracitoplasmático
    b) Aumento del pH intracelular

c) **Disminución de la fosforilación oxidativa**

d) Activación de glucolisis anaeróbica

17. **Una mujer de 69 años ha sufrido ... transitorias en los últimos 3 meses. En la ... derecha se reseca una placa ateromatosa, aspecto firme, color amarillo oscuro a simple vista. Microscópicamente, que sustancias podemos encuentra con abundancia:**

a) Triglicéridos e lipoproteínas

b) **Colesterol y esteres de colesterol**

c) Fosfolípidos y ácidos grasos libres

d) Triglicéridos y ...

18. **Una mujer de 22 años esta embarazada. En la ecografía fetal de 13 semanas muestra que el útero mide 7x4x3cm. En el parto en término, el útero mide 34x18x12cm. ¿Cuál de los siguientes procesos celulares ha contribuido para el incremento de tamaño del útero?**

a) **Hipertrofia del músculo liso uterino**

b) Hipertrofia del estroma endometrial

c) Hiperplasia del endotelio vascular

d) Hiperplasia atípica del endometrio.

19. **Hombre 73 años consulta por dolor abdominal en el examen muestra el hígado dos veces el tamaño normal, amarillo de superficie lisa. Microscópicamente se muestra numerosas vacuolas transparentes en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la posible causa de las alteraciones de lo paciente?**

a) Infección por el virus de hepatitis

b) Alimentación rica en fibras

c) **Consumo de alcohol**

d) Anemia hemolítica

20. **Mujer de 78 años perdió el conocimiento de repiente, no podría hablar ni mover el brazo derecho. Ha dos meses una tomografía mostro una gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya obtenido lugar en el encéfalo?**

a) Necrosis gangrenosa con formación de cavitaciones

b) **Infiltrados neutrofílicos con restos licuados**

c) Lesión granulomatosa que presenta células multinucleadas

d) Granuloma que presentan centralmente depósitos de inmunocomplejos.

Tipos de enzimático = necrose caseosa necrose licuefativa

QUESTÃO 1
DOIS RASGOS MACROSCOPICOS PRESENTES EN EL HIGADO COM ESTEATOSIS?
Bordes regulares, cápsula densa e peso aumentado

Bordes regulares; cápsula densa

QUESTÃO 2
DOIS PATRONES DE NECROSIS QUE PRESENTAM PRIMARIAMENTE DESNATURALIZACION DE PROTEÍNAS ?
Necrosis coagulativo e Necrosis grangrena seca

Necrosis coagulativo
Necrosis gangrena seca

QUESTÃO 3
DOIS CAMBIOS PATOLOGICOS QUE PODEM SOFRER AS PLACAS ATEROSCLEROTICAS?
Hemorragia, formación de aneurisma, ruptura é erosión

Hemorragia; Ruptura

4- LA CARIOSIS É ES UN CAMBIO NUCLEAR CARACTERIZADO POR PERDIDA DE BASOFILIA DE LA CROMATINA DEBIDO A LA DISOLUCIÓN NUCLEAR POR DEGRADACIÓN ENZIMATICA.

Basófilo → Cariólisis

5- DESPUES DE LA MENOPAUSIA, SE PUEDE OBSERVAR CAMBIOS EN LAS HORMONAS POR PERDIDA DE ESTIMULOS HORMONALES, LO QUE CONDUCE A UM PROCESSO ADAPTATIVO QUE CORRESPONDE A atrofia fisiologica

Atrofia fisiológica

6- TINCION CON CARMÍN DE BEST O PAS DA LUGAR A UNA COLORACIÓN ROSA VIOLÁCEO
LEMBRAR QUE ELA DA UMA COLORACION ROSA VIOLACEA AO DEPOSITO DE GLUCOSA → Carmin de Best O PAS

7- EL AUMENTO DE LA GLUCÓLISIS ANAERÓBICA PRODUCE ACUMULACIÓN DE LO QUE PRODUCE EL PH INTRACELULAR Y GENERA ACUMULACIÓN DE LA CROMATINA NUCLEAR....ACIDO LATICO

Ácido Láctico

Slide 1 pág. 30

8- quadro comparativo
CARACTERISTICAS ENTRE APOPTOSIS E NECROSIS

	Membrana Plasmática	Inflamación
Necrosis	Ruptura	Tiene
Apoptosis	Membrana Conservada ou se formam Corpos apoptoticos	No tiene

membrana conservada (Forman cuerpos Apoptoticos)

No tiene

Opções do quadro:
Falla de bomba de sodio potassio, Sintese de proteinas aumentadas, Piroptosis, Presencia de citrocromo c, Colesterol, LDL baixo, Gangrena seca, Necrosis caseosa, Division celular aumentada

9- La muerte causada por aumento de la permeabilidad de menbrana mitocondrial externa causa as vezes la salida de de unas proteinas ao citosol
R: Presencia de citrocromo c

10-Paciente de 70 anos presenta un cuadro respiratorio de meses de evolución, y a nivel de vertice del pulmon derecho se observan imagens granulomatosas
R: Necrosis caseosa

11-Mulher de 53 anos, sin antecendesntes de interés, vai ao seu médico para una revision rutinaria, presenta una présion arterial de 150-95, y se evidencia hallazgos electrocardiograficos sugestivos de cardiomegalia.
R: sinteses de proteinas aumentadas

De marcar
12- Al microscopio optico al un patron de lesión celular reversible se podrá observar
a- vacuolas lipidicas transparentes no citoplasma da celula
b- presencia de massas de fosfolipidos e mais figuras de mielina
c- calcificacion de acido plasmico que genera carbons de calcio
d-aumento de de eusinofilia por perda de rna en el citoplasma

13- los tejidos que tienem capacidade de crescimento hiperplasico e se classifican como estables.
a- musculos esqueletico, tubulos renales, y ganglios linfaticos
b- musculo cardiaco, acidos pancreaticos e epidermis
c- tejido cicatricial, cerebro e medula suprarrenal
d- foliculos tiroideos, celulas endoteliales, hepatocitos

14- QUE TRANSTORNO CLINICO SE ASSOCIA COM APOPTOSIS PATOLOGICA
A- INFECCION EN PÉ DERECHO EN UN PACIENTE DIABETICO
B-PACIENTE COM DEMENCIA POR ENFERMEDAD DE PARKINSON
C-VERRUGAS CUTÁNEAS EN UN PACIENTE CON INFECCION POR PAPILOMAVIRUS
D- DISMINUICION DE FLUXO SANGUINEO MIOCARDICO POR ATEROSCLEROSIS CORONARIA

15- CUAL DE LOS SIGUIENTES ES UN FACTOR DE RIESGO ADQUIRIDO PARA ELDESARROLLO DE ATEROMAS

A- SEXO MASCULINO ✗ congenito
B- CONSUMO MODERADO DE ALCOOL – esteatosis
C- SINDROME METABOLICA ✓
D- AUMENTO DO COLESTEROL LDL ✓

16- CON RESPECTO A ATROFIA PARDA, QUAL DE LOS SEGUINTES ÉS CORRECTO

A- OCORRE SITUACIONES DE PERDA DE ESTIMULACION ENDOCRINA
B- ALGUNOS DE LOS RESIDUOS CELULARES DEL PROCESSO CONSTITUEN LOS GRANULOS DE HEMOSIDERINA lipofuscina
C- LAS CELULAS ATROFIADAS INTENTAN AUMENTAR A DEMANDA NUTRICIONAL
D- VA ACOMPANHADA DE UN INCREMENTO DE VACUOLAS AUTOFAGICAS ✓

17- EN EL ESTUDIO DE INFECCION POR VIH SE OBSERVA LOS LINFOCITOS T CITOTOXICOS PROVOCANDO A MORTE DE LAS CELULAS INFECTADAS PELOS VIRUS, QUAL DE LAS SEGUINTES SUBSTANCIAS INICIA A MORTE CELULAR PROGRAMADA..

A- BCL12 ptn antiapopt q vai junto ao Bak e Bax
B- ENDONUCLEASAS é uma enzima q não inicia
C- CASPASAS ✓
D- GEN TP53 marcador dano

apoptoses Patologia

18- PACIENTE DE SEXO FEMININO DE 30 ANOS DE EDAD CON DIAGNOSTIVO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, ENFERMEDAD DONDE SE PRODUCEN REACCIONES INFLAMATORIAS DE ETIOLOGIA INMUNOLÓGICA

A- NECROSIS FIBRINOIDE reações imunes
B- GRANGRENA HUMEDA
C- INFARTO BLANCO
D- GRANULOMA NECROSADO caseosa

19- HOMBRE DE 50 ANOS CON ANTECENDENTES DE ANGINA INSTABLE SUFRIÓ UN INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO, SE ADMINISTRA TERAPIA ANTROPOLITICA PARA RESTAURAR EL GRUPO SANGUINEO CORONARIO, APESAR DE ESTA TERAPIA, LA EXTENSION DE LA LESION PUEDE AUMENTAR DEBIDO A LA SEGUINTE ANOMALIA CELULAR..

A- AGRUPACION DE CROMATINA NUCLEAR
B- MAYOR FORMACION DE RADICALES LIVRES Se formam EROs | tem a ver com O2
C-PERDIDAS DE ELEMENTOS INTERMEDIOS CITOESQUELETICOS
D- DISMINUICION DEL PH INTRACELULAR POR NECROSIS

20- EN UM EXPERIMENTO SE APLICA ENERGIA RADIANTE EN FORMAS DE RAIOS X A CELULAS COM ATIVIDADES METABOLICAS, ESTO PROVOCA UN DAÑO CELULAR CAUSADAS POR ESPECIES REATIVAS DE OXIGENIO CUAL DE LAS SEGUINTES ENZIMAS INTRACELULARES AJUDAN A PROTEGER LAS CELULAS DESTE TIPO DE DANO..

A- ENDONUCLEASAS
B- METALES Ferro e cobre
C- GLUTATION PEROXIDASE
D- VITAMINA C frutas cítricas y aceite de oliva

Superóxido

peróxido

P1 Turma C

QUESTÃO 1
DOIS RASGOS MACROSCOPICOS PRESENTES EN EL HIGADO COM ESTEATOSIS?
Bordes regulares, cápsula densa e peso aumentado

QUESTÃO 2
DOIS PATRONES DE NECROSIS QUE PRESENTAM PRIMARIAMENTE DESNATURALIZACION DE PROTEÍNAS ?
Necrosis coagulativo e Necrosis grangrena seca

QUESTÃO 3
DOIS CAMBIOS PATOLOGICOS QUE PODEM SOFRER AS PLACAS ATEROSCLEROTICAS?
Hemorragia, formación de aneurisma, ruptura e erosión

4- LA CARIOSIS É ES UN CAMBIO NUCLEAR CARACTERIZADO POR PERDIDA DE BASOFILIA DE LA CROMATINA DEBIDO A LA DISOLUCIÓN NUCLEAR POR DEGRADACIÓN ENZIMATICA.
5- DESPUES DE LA MENOPAUSIA, SE PUEDE OBSERVAR CAMBIOS EN LAS HORMONAS POR PERDIDA DE ESTIMULOS HORMONALES, LO QUE CONDUCE A UM PROCESSO ADAPTATIVO QUE CORRESPONDE A atrofia fisiologica

6- TINCION CON CARMÍN DE BEST O PAS DA LUGAR A UNA COLORACIÓN ROSA VIOLÁCEO
LEMBRAR QUE ELA DA UMA COLORACION ROSA VIOLACEA AO DEPOSITO DE GLUCOSA

7- EL AUMENTO DE LA GLUCÓLISIS ANAERÓBICA PRODUCE ACUMULACIÓN DE LO QUE PRODUCE EL PH INTRACELULAR Y GENERA ACUMULACIÓN DE LA CROMATINA NUCLEAR....ACIDO LATICO

8- quadro comparativo
CARACTERISTICAS ENTRE APOPTOSIS E NECROSIS

	Membrana Plasmatica	Inflamacion
Necrosis	Rotura	Tiene
Apoptosis	Membrana Conservada ou se formam Corpos apoptaticos	No tiene

Opções do quadro:
Falla de bomba de sodio potassio, Sintese de proteinas aumentadas, Piroptosis, Presencia de citrocromo c, Colesterol, LDL baixo, Gangrena seca, Necrosis caseosa, Division celular aumentada

9- La muerte causada por aumento de la permeabilidad de menbrana mitocondrial externa causa as vezes la salida de de unas proteinas ao citosol
R: Presencia de citrocromo c

10-Paciente de 70 anos presenta un cuadro respiratorio de meses de evolución, y a nivel de vertice del pulmon derecho se observan imagens granulomatosas
R: Necrosis caseosa

11-Mulher de 53 anos, sin antecendesntes de interés, vai ao seu médico para una revision rutinaria, presenta una présion arterial de 150-95, y se evidencia hallazgos electrocardiograficos sugestivos de cardiomegalia.
R: sinteses de proteinas aumentadas

De marcar
12- Al microscopio optico al un patron de lesión celular reversible, se podrá observar
a- vacuolas lipidicas transparentes no citoplasma da celula
b- presencia de massas de fosfolipidos e mais figuras de mielina
c- calcificacion de acido plasmico que genera carbons de calcio
d-aumento de de eusinofilia por perda de rna en el citoplasma

13- los tejidos que tienem capacidade de crescimento hiperplasico e se classifican como estables.
a- musculos esqueletico, tubulos renales, y ganglios linfaticos
b- musculo cardiaco, acidos pancreaticos e epidermis
c- tejido cicatricial, cerebro e medula suprarrenal
d- foliculos tiroideos, celulas endoteliales, hepatocitos

14- QUE TRANSTORNO CLINICO SE ASSOCIA COM APOPTOSIS PATOLOGICA
A- INFECCION EN PÉ DERECHO EN UN PACIENTE DIABETICO
B-PACIENTE COM DEMENCIA POR ENFERMEDAD DE PARKINSON
C-VERRUGAS CUTÁNEAS EN UN PACIENTE CON INFECCION POR PAPILOMAVIRUS
D- DISMINUICION DE FLUXO SANGUINEO MIOCARDICO POR ATEROSCLEROSIS CORONARIA

15- CUAL DE LOS SIGUIENTES ES UN FACTOR DE RIESGO ADQUIRIDO PARA EL DESARROLLO DE ATEROMAS
A- SEXO MASCULINO
B- CONSUMO MODERADO DE ALCOOL
C- SINDROME METABOLICA
D- AUMENTO DO COLESTEROL LDL

16- CON RESPECTO A ATROFIA PARDA, QUAL DE LOS SEGUINTES ÉS CORRECTO
A- OCORRE SITUACIONES DE PERDA DE ESTIMULACION ENDOCRINA
B- ALGUNOS DE LOS RESIDUOS CELULARES DEL PROCESSO CONSTITUEN LOS GRANULOS DE HEMOSIDERINA
C- LAS CELULAS ATROFIADAS INTENTAN AUMENTAR A DEMANDA NUTRICIONAL
D- VA ACOMPANHADA DE UN INCREMENTO DE VACUOLAS AUTOFAGICAS

17- EN EL ESTUDIO DE INFECCION POR VIH SE OBSERVA LOS LINFOCITOS T CITOTOXICOS PROVOCANDO A MORTE DE LAS CELULAS INFECTADAS PELOS VIRUS, QUAL DE LAS SEGUINTES SUBSTANCIAS INICIA A MORTE CELULAR PROGRAMADA..
A- BCL12
B- ENDONUCLEASAS
C- CASPASAS
D- GEN TP53

18- PACIENTE DE SEXO FEMININO DE 30 ANOS DE EDAD CON DIAGNOSTIVO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, ENFERMEDAD DONDE SE PRODUCEN REACCIONES INFLAMATORIAS DE ETIOLOGIA INMUNOLÓGICA
A- NECROSIS FIBRINOIDE
B- GRANGRENA HUMEDA
C- INFARTO BLANCO
D- GRANULOMA NECROSADO

19- HOMBRE DE 50 ANOS CON ANTECENDENTES DE ANGINA INSTABLE SUFRIÓ UN INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO, SE ADMINISTRA TERAPIA ANTROPOLITICA PARA RESTAURAR EL GRUPO SANGUINEO CORONARIO, APESAR DE ESTA TERAPIA, LA EXTENSION DE LA LESION PUEDE AUMENTAR DEBIDO A LA SEGUINTE ANOMALIA CELULAR..
A- AGRUPACION DE CROMATINA NUCLEAR
B- MAYOR FORMACION DE RADICALES LIVRES
C-PERDIDAS DE ELEMENTOS INTERMEDIOS CITOESQUELETICOS
D- DISMINUICION DEL PH INTRACELULAR POR NECROSIS

20- EN UM EXPERIMENTO SE APLICA ENERGIA RADIANTE EN FORMAS DE RAIOS X A CELULAS COM ATIVIDADES METABOLICAS, ESTO PROVOCA UN DAÑO CELULAR CAUSADAS POR ESPECIES REATIVAS DE OXIGENIO
CUAL DE LAS SEGUINTES ENZIMAS INTRACELULARES AJUDAN A PROTEGER LAS CELULAS DESTE TIPO DE ANO..
A- ENDONUCLEASAS
B- METALES
C- GLUTATION PEROXIDASE
D- VITAMINA C